

Infections liées aux cathéters veineux centraux

Méthodologie, glossaire, Q1, Q2 & Q3



Champ : réactualisation de la 12^e conférence de consensus SRLF de 1994 sur les infections liées aux cathéters (ILC) veineux centraux en réanimation, chez l'adulte et l'enfant. 5 questions. Coordination : J.-F. Timsit (adulte), P. Durand (pédiatrie).

Méthodologie : chaque affirmation est cotée par un code **Niveau-Score** tel que [1-b] [2-a] [3-c] — légende publiée intégralement par la source (grille ci-dessous), reproduite ici sans aucune interprétation ajoutée. Convention de couleur de cette fiche : coloré selon le chiffre (niveau). Plusieurs points sont explicitement signalés « point non résolu » par la source (littérature insuffisante, aucune recommandation) — reproduits tels quels [point non résolu], jamais convertis en une fausse recommandation gradée.

Grille	Définition
Score d'évaluation (type d'étude)	a — études prospectives, contrôlées, randomisées ; b — études non randomisées, comparaisons simultanées ou historiques de cohortes ; c — mises au point, revues générales, éditoriaux, séries substantielles de cas publiés dans des revues avec comité de lecture et révisés par des experts extérieurs ; d — publications d'opinions publiées dans des journaux ou livres sans comité de lecture.
Niveau de recommandation	1 — justifiée par des preuves scientifiques indiscutables ; 2 — justifiée par des preuves scientifiques et le soutien consensuel des experts ; 3 — ne reposant pas sur des preuves scientifiques adéquates mais soutenue par les données disponibles et l'opinion des experts.

Abréviation	Signification
ILC / CVC	Infection liée au cathéter / Cathéter veineux central
AB / HC	Antibiotique / Hémocultures
SCN / BGN	Staphylocoques à coagulase négative / Bacilles Gram négatif
ETO	Échographie transœsophagienne

Question 1 — Sur quels éléments définir une infection sur CVC, et quelle(s) technique(s) pour en affirmer le diagnostic ?

L'infection liée au CVC est définie par la présence de micro-organismes à la surface interne et/ou externe du CVC, responsable d'une infection locale et/ou générale. Les signes cliniques locaux et/ou généraux peuvent s'accompagner ou non d'une hémoculture positive, et inversement. À l'exclusion du pus au point de ponction, aucun signe clinique ne permet à lui seul d'affirmer l'infection sur CVC [2-b] — le lien avec la présence de micro-organismes requiert des analyses microbiologiques.

Techniques de culture du cathéter (nécessitent son ablation) : la culture qualitative en milieu liquide ne distingue pas contamination, colonisation et infection, et doit être abandonnée [1-b]. D'autres méthodes existent : culture semi-quantitative sur milieu gélosé, ou culture quantitative en milieu liquide après rinçage endoluminal ou après « vortexage » ou sonication. Le seuil de la technique semi-quantitative (méthode de Maki, > 15 ufc) n'explore que la portion extraluminale et n'a été qu'incomplètement validé en réanimation. Le seuil > 10³ ufc/ml de la technique par « vortexage », déterminé à l'aide d'une classification clinique des malades bactériémiques ou non en réanimation, possède un meilleur rapport valeur diagnostique/coût et devrait être préférée [2-b].

Le taux élevé d'ablations injustifiées (3/4 des cathéters retirés à tort) a fait proposer des techniques « cathéter en place », envisageables uniquement en l'absence d'état de choc, de tunnelite, de thrombophlébite et d'endocardite [2-c] : la culture des prélèvements cutanés au site de ponction a une bonne valeur prédictive négative [1-b] (la surveillance systématique du point d'insertion, sans point d'appel infectieux, n'a en revanche aucune indication en routine [1-b]) ; un rapport de comptes bactériens > 5 entre hémoculture centrale et périphérique (hémocultures quantitatives simultanées) est prédictif et spécifique [2-b] ; un délai différentiel de positivité d'au moins 2 h en faveur de l'hémoculture centrale est hautement prédictif (sensibilité et spécificité > 90 %) [1-b] — pour les cathéters de courte durée (< 14 j, contamination surtout extraluminale), des études complémentaires restent nécessaires pour confirmer cette valeur diagnostique [point non résolu]. Les hémocultures par le cathéter seul ne permettent pas de diagnostiquer une ILC non bactériémique [2-c].

Infections liées aux cathéters veineux centraux

Méthodologie, glossaire, Q1, Q2 & Q3



Situation	Critères
ILC sans bactériémie [2-c]	Culture de CVC $\geq 10^3$ ufc/ml, ET régression totale ou partielle des signes infectieux dans les 48 h suivant l'ablation, OU purulence de l'orifice d'entrée / tunnelite.
ILC bactériémique [2-c]	Bactériémie survenant dans les 48 h encadrant le retrait du CVC, ET (culture positive du site d'insertion au même germe, OU culture du CVC $\geq 10^3$ ufc/ml du même germe, OU rapport hémoculture centrale/périphérique ≥ 5 , OU délai différentiel de positivité ≥ 2 h).
Infection NON liée au CVC	CVC stérile ; OU culture du CVC positive à une souche différente de celle du sang et/ou d'un autre foyer infectieux présent au moment de l'ablation du CVC, sans régression du syndrome infectieux à l'ablation ; OU culture du CVC positive à une souche identique à celle trouvée dans un autre foyer infectieux identifié au moins 48 h avant l'ablation du CVC — qu'il soit ou non responsable de bactériémie — sans régression du syndrome infectieux à l'ablation (colonisation secondaire à partir d'un foyer à distance).

Question 2 — Importance relative des mécanismes impliqués dans les ILC

Voies de contamination : la voie cutanée (extraluminale) est la plus fréquente, survenant lors de la pose ou par colonisation secondaire du site d'insertion. La contamination endoluminale, secondaire aux manipulations septiques des raccords (exceptionnellement à un liquide de perfusion contaminé), devient prépondérante au-delà de 3 semaines de cathétérisme [2-b]. La voie hématogène est rare [2-b].

Mécanismes de colonisation : le contact initial sang/cathéter entraîne l'adsorption de protéines plasmatiques (albumine, adhésines) à la surface du cathéter, puis la formation d'un réseau fibrino-plaquettaire colonisé progressivement par leucocytes et collagène, organisé en manchon. Des protéines plasmatiques et plaquettaires (fibrine, fibrinogène, fibronectine, vitronectine, laminine, thrombospondine, collagène) favorisent l'adhérence bactérienne, selon des mécanismes spécifiques partiellement connus, multiples et variables d'une bactérie à l'autre ; certaines bactéries adhèrent aussi de façon non spécifique en s'enchantant dans une substance polysaccharidique (« slime »). In vitro, le polyuréthane et les élastomères de silicone sont les matériaux les moins propices à l'adhésion bactérienne.

Question 3 — Facteurs de risque, incidence, pronostic et conséquences des ILC en réanimation

Incidence : par leur fréquence et leur mortalité, les ILC font partie des 3 principales infections acquises en réanimation [1-b] ; les bactériémies liées aux CVC représentent 1/3 des bactériémies acquises en réanimation [1-b]. Les cocci à Gram positif (surtout SCN) sont actuellement la principale cause ; entérobactéries et *Pseudomonas* représentent environ 1/3 des cas, surtout en territoire cave inférieur.

Densité d'incidence médiane en France : bactériémies primaires 3 à 9/1000 j-cathéter ; bactériémies liées au CVC 1 à 2/1000 j-cathéter ; cultures positives de CVC en moyenne 7/1000 j-cathéter. Chez l'enfant, densité proche de 5/1000 j-cathéter (grande disparité selon les unités, plus élevée en unités de brûlés). L'épidémiologie des infections sur cathéter de dialyse en réanimation est mal connue et justifie des études complémentaires.

Facteurs de risque	Détail
Liés au patient	Sexe masculin [3-b] ; immunodépression [3-c] ; surtout la densité des soins [2-b] (facteurs mal évalués dans la littérature).
Liés à la pose	Polyuréthane/élastomères de silicone → moins d'ILC que le PVC. Voies fémorale et probablement jugulaire interne : risque supérieur à la voie sous-clavière [1-a] (non démontré chez l'enfant [point non résolu] ; chez l'adulte, aucune étude ne démontre la supériorité de la jugulaire interne sur la fémorale [2-b]). Asepsie chirurgicale à la pose : moins d'ILC en son absence [1-a].
Liés à l'utilisation	Fréquence des manipulations de la ligne [2-c]. Antibiotrophylaxie à la pose : ne réduit pas le risque [2-a] ; antibiotiques IV pendant l'insertion : risque moindre [2-b]. Durée de cathétérisme : risque cumulé croissant [1-b] (risque instantané probablement non constant, possiblement croissant pour les cathéters de longue durée [3-c]). Cathéters artériels pulmonaires : risque accru au-delà du 4 ^e jour [2-b].

Morbidité, mortalité : les ILC bactériémiques sont associées à une augmentation du risque de décès en réanimation estimée entre 4 et 20 %, et à une prolongation de séjour de 5 à 20 jours [1-b] (estimation rendue difficile par de nombreux facteurs confondants — gravité et évolution des patients, adéquation de l'antibiothérapie [1-b]). Les conséquences sont plus importantes en cas d'infection à *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas sp.* et *Candida sp.* [1-b].



Question 4 — Méthodes de prévention de l'ILC recommandées en réanimation

5.1 — Choix du matériel : l'emploi de matériaux moins thrombogènes (polyuréthane, élastomère de silicone) est recommandé [1-b]. Les cathéters imprégnés d'héparine n'ont pas fait la preuve de leur efficacité anti-infectieuse chez l'adulte [2-b] (ils diminuent le risque de thrombose [1-a]). Chez l'enfant, les données disponibles suggèrent que le recours à des modèles imprégnés d'héparine et/ou à une héparinisation des solutions de perfusion réduit les complications thrombotiques et les bactériémies pour les cathéters de petit diamètre (< 5 Fr) par voie fémorale [2-b].

5.2 — Cathéters imprégnés d'antibiotiques/antiseptiques : l'imprégnation par chlorhexidine-sulfadiazine argent ou association minocycline-rifampicine diminue le risque d'infection de moitié [1-a]. Cependant, quoique non démontré, ce type de matériau pourrait favoriser l'émergence de bactéries résistantes [2-c] — en particulier la rifampicine à dose sub-inhibitrice (antibiotique majeur en cas d'infection sur prothèse) [1-b]. En conséquence, l'utilisation de cathéters imprégnés d'agents anti-infectieux n'est pas recommandée en première intention ; celle des cathéters imprégnés de chlorhexidine-sulfadiazine argent est réservée aux unités où l'incidence des ILC reste élevée malgré le renforcement des mesures préventives non anti-infectieuses [2-c] (cathéters imprégnés d'antibiotiques : études complémentaires nécessaires [point non résolu]).

5.3 — Technique de pose : aseptie chirurgicale, y compris lors des échanges sur guide [1-a]. Peau détergée au savon antiseptique puis badigeonnée (povidone iodée, chlorhexidine ou alcool) [1-a] ; contact jusqu'à peau sèche, ≥ 2 min pour la povidone iodée [1-b]. Solvants (acétone...) déconseillés avant insertion/pansements [1-a]. Champs stériles larges [1-a]. La tunnelisation diminue le risque pour les cathéters jugulaires internes et fémoraux [1-a] (sans intérêt pour les sous-claviers [2-a]). Changement sur guide : mêmes conditions que la pose initiale [2-c], gants stériles changés à la mise en place du nouveau cathéter [2-c]. Le changement systématique à intervalle régulier (sur guide ou nouveau site) est à proscrire [1-a]. Le risque des cathéters multilumières n'est pas supérieur à celui des monolumières dans les études randomisées [2-a].

5.4 — Site d'accès vasculaire : la voie sous-clavière est préférée dès que la durée prévue dépasse 5-7 j, si le risque de barotraumatisme/ponction artérielle non compressible n'est pas trop important [1-a]. Si le risque mécanique est élevé, la voie jugulaire interne peut être envisagée [2-b] (tunnelisation alors recommandée [1-a]). La voie fémorale est discutée si le risque cave supérieur est élevé (tunnelisation recommandée) [2-a]. La voie axillaire mérite une évaluation complémentaire.

5.5 — Pansement du site d'insertion : l'efficacité de l'occlusion du site est démontrée [1-a] ; le type de pansement n'est pas décisif, mais un pansement semi-perméable transparent permet la surveillance visuelle/manuelle. L'intérêt des éponges imprégnées de chlorhexidine n'est pas tranché [point non résolu]. Intervalle optimal de changement : au moins 72 h. Dates de pose et de réfection notées. Le site d'insertion du cathéter doit être surveillé quotidiennement [2-c].

5.6 — Choix de l'antiseptique : une méta-analyse récente suggère la supériorité de la chlorhexidine sur la povidone iodée [1-a] (chlorhexidine souvent fortement dosée ou associée à l'alcool dans les études incluses [2-a]). La povidone iodée-alcool semble supérieure à la povidone iodée seule [2-a] ; aucune étude n'a comparé povidone iodée-alcool et chlorhexidine-alcool [point non résolu].

5.7 — Entretien de la ligne veineuse : limiter les manipulations [2-b]. L'éloignement des sites d'injection (prolongateur non changé) réduit la contamination [2-b]. Intervalle optimal de changement de ligne : 2 à 3 j [1-b] (délais plus longs, 4 à 7 j, suggérés par certaines études, à confirmer en réanimation [2-b]). Remplacer les tubulures ayant servi à des dérivés sanguins ou lipides (y compris propofol [2-b]) dans les 24 h [2-c]. L'efficacité des filtres antimicrobiens n'est pas démontrée [1-a]. L'héparinisation générale diminue le risque de thrombose sur CVC [1-a] (effet sur le risque infectieux suggéré par une méta-analyse mais non démontré [point non résolu]).

5.8 — Politique générale de prévention : limiter les indications de pose des CVC et cathéters de Swan-Ganz, ablation la plus précoce possible [1-b]. Protocoles écrits pour la pose, l'entretien et l'utilisation, élaborés en équipe et respectés par tous [1-b]. Les facteurs de risque étant essentiellement exogènes, cette infection nosocomiale se prête particulièrement aux programmes d'amélioration continue de la qualité : impact démontré d'équipes formées à la prise en charge des cathéters [1-a] et de programmes d'éducation, comportant une formation aux bonnes pratiques d'hygiène et des directives précises sur la pose des différents accès vasculaires (préparation du matériel, désinfection de la peau, précautions stériles maximales, techniques détaillées d'insertion), sur leur utilisation (désinfection systématique des mains, manipulations des rampes) et sur les soins qui leur sont apportés (schéma de remplacement, type et fréquence de réfection des pansements) [1-b].

5.9 — Cathéter de Swan-Ganz et cathéter artériel : toutes les règles précédentes s'appliquent. Le site jugulaire est préférable au sous-clavier pour la surveillance hémodynamique péri-opératoire par Swan-Ganz (balance risque infectieux/complications mécaniques). Manchons plastifiés protecteurs recommandés [2-a]. Le changement systématique du Swan-Ganz ou des cathéters artériels n'est pas recommandé [2-c]. Sets de pression à usage unique préférables [2-b] ; systèmes d'injection clos pour les bolus (Swan-Ganz et système Picco®) [2-c]. Pas de soluté glucosé pour la purge des sets de pression [1-b]. Changement de l'ensemble tubulures/set de pression/robinet tous les 4 j [2-b].

5.10 — Cathéters de dialyse : très peu de données en réanimation. Utilisation pour perfusion/prélèvement sanguin hors séances de dialyse non recommandée [2-c]. Changement systématique non recommandé [2-b].



Question 5 — Stratégie diagnostique et thérapeutique initiale en cas de présomption d'infection sur CVC

L'attitude diagnostique et le traitement initial résultent de la confrontation des signes locaux, des manifestations cliniques générales et des résultats microbiologiques (locaux et hémocultures — prélevées systématiquement, au minimum en périphérie, de préférence simultanément par le cathéter, devant toute suspicion). Certains facteurs de risque doivent également être pris en compte, comme la durée de maintien du cathéter et le site d'implantation ; l'évolution des signes cliniques (persistance, aggravation) et la nature du ou des micro-organismes en cause doivent être intégrées dans les choix thérapeutiques. Deux questions se posent initialement : faut-il retirer le cathéter suspect ? faut-il prescrire une antibiothérapie ? En pratique, la stratégie initiale dépend de la présence de signes locaux d'une part et de la sévérité du syndrome septique d'autre part.

6.1.1 — L'ablation immédiate d'un cathéter présumé infecté s'impose : en présence de signes locaux francs (cellulite, tunnelite, collection purulente) [1-b] ; en cas d'infection compliquée d'emblée (thrombophlébite, endocardite [1-b] ; germes à haut risque — bactériémie à *S. aureus*, *Pseudomonas* ou *Candida* [1-b]) ; devant des signes de gravité (choc septique) sans autre cause apparente [1-b] ; en cas de bactériémie chez un porteur de prothèse endovasculaire ou de valve cardiaque [1-c] ou immunodéprimé [point non résolu].

6.1.2 — En l'absence de signes locaux et généraux de gravité, plusieurs attitudes sont possibles (dans ces situations à présomption faible/modérée, la probabilité de retirer à tort un cathéter stérile est très élevée, 80 % des cas [1-b] — la nécessité d'implanter un nouveau cathéter sur un autre site exposant par ailleurs à des risques de complications mécaniques non négligeables) : le changement de cathéter sur guide (confirme/infirmes en conservant l'abord vasculaire, solution temporaire en attendant 24 h les résultats microbiologiques, surtout justifiée si suspicion faible/modérée ou germe à faible risque) ; ou une attitude conservatrice (cathéter laissé en place, au moins dans un premier temps) : prélèvements locaux — du site d'insertion, du pavillon — qui, lorsqu'ils sont négatifs, permettent d'éliminer l'infection, et/ou hémocultures couplées du sang prélevé en périphérie et par le cathéter.

6.2 — Antibiothérapie et conduite selon les résultats microbiologiques : en présence de signes de gravité (sepsis sévère, choc), de complications (tunnelite, thrombophlébite, endocardite) ou de signes locaux patents (suppuration), une antibiothérapie probabiliste est débutée immédiatement [1-b] (dirigée notamment contre les Gram positifs, guidée par l'examen direct et l'écologie, réévaluée à réception des résultats définitifs [1-b]). Si l'infection est confirmée avec hémocultures positives à un germe à haut risque (*S. aureus*, *Candida sp.*, *Pseudomonas sp.*, *Corynebacterium JK*, *Bacillus sp.*), le cathéter est enlevé s'il ne l'a pas déjà été et le traitement adapté est poursuivi.

En cas de septicémie à *S. aureus*, une échocardiographie transœsophagienne (transthoracique chez le jeune enfant) est recommandée pour vérifier l'état valvulaire [1-b] (fréquence d'endocardite associée estimée entre 5 et 20 %), avec un Doppler veineux. Sans lésion valvulaire ni thrombophlébite, et si le contrôle de l'infection est rapide (hémocultures négativées et régression en 48-72 h), un traitement « court » (10-14 j) paraît suffisant [1-b] (complications → traitement plus prolongé, cf. Figure 1). Pour *Acinetobacter baumannii* et les entérobactéries du groupe III, les données sont insuffisantes mais suggèrent un traitement [3-c].

6.2.3 — Bactériémie à staphylocoque à coagulase négative (probablement liée au cathéter) : l'attitude la plus sûre est l'ablation du cathéter — une bactériémie isolée avec régression rapide après ablation ne nécessite pas nécessairement d'antibiothérapie, en l'absence de facteurs de risque associés [2-c]. Un changement sur guide, voire un maintien en place sous antibiothérapie adaptée, peut être envisagé (attitude fréquente en cas de cathéter d'alimentation parentérale prolongée ou en hématologie) — la méthode du « verrou antibiotique » n'a toutefois pas été évaluée en réanimation et n'a pas d'indication reconnue dans ce contexte [2-c] (même raisonnement probable pour entérobactéries du groupe I/II et entérocoques [3-c]).

6.2.4 — En l'absence de bactériémie, de signes de gravité et de germe à haut risque (recommandations fondées sur avis d'experts, aucune étude ne permet de répondre formellement) : une infection locale non compliquée nécessite un traitement local désinfectant et une surveillance après retrait — la régression rapide (48 h) peut constituer le seul traitement, sous surveillance attentive et en l'absence d'immunodépression [2-c] (antibiothérapie généralement non nécessaire, sauf signes généraux francs d'emblée ou aggravation/réapparition de signes dans les 48 h, durée alors inconnue). Si un changement sur guide a été fait : remplacement sur nouveau site si colonisation significative du 1^{er} cathéter (antibiothérapie généralement non nécessaire sans bactériémie) ; si SCN isolé sur le 1^{er} cathéter, le 2^e peut être laissé en place sous antibiothérapie, surveillance renforcée, retrait imposé si persistance des signes généraux [2-c]. Cathéter laissé en place (présomption faible/modérée), sans suppuration/bactériémie/signes de gravité : surveillance simple, antibiothérapie non recommandée, prélèvements renouvelés au moindre doute. Dans tous les cas, la recherche d'un autre foyer infectieux est nécessaire.

Figure 1 — Algorithme décisionnel (reproduit en tableau Étape/Situation/Conduite depuis le schéma source, page 7)

Étape / Situation	Conduite
1 — Suspicion d'ILC, état de choc / sepsis sévère / écoulement purulent (tunnelite)	Ablation immédiate du cathéter + antibiothérapie probabiliste (vancomycine ± β-lactamines + aminosides ; évaluer l'intérêt d'un antifongique) → culture du cathéter.
1 — Suspicion d'ILC, pas de signe de gravité	Selon la stratégie retenue : échange du cathéter sur guide (→ culture du cathéter) OU culture du point de ponction.

Infections liées aux cathéters veineux centraux

Q4 & Q5 — Prévention, stratégie diagnostique/thérapeutique, Figure 1 & sources



Étape / Situation	Conduite
2 — Culture du point de ponction négative	Surveillance ; recherche d'un autre site infecté (± changement sur guide).
2 — Culture du point de ponction positive	Hémocultures périphérique + centrale couplées (ratio quantitatif > 5:1 et/ou délai de positivité > 2 h).
3 — Hémocultures couplées négatives (ratio ≤ 5:1 et délai ≤ 2 h)	Recherche d'une autre infection.
3 — Hémocultures couplées positives (ratio > 5:1 et/ou délai > 2 h)	I.L.C. certaine.
4 — Culture du cathéter négative (après ablation ou échange sur guide)	Recherche d'une autre infection.
4 — Culture du cathéter positive, résultat des hémocultures négatif (ablation du CVC si échange sur guide)	« Amélioration après ablation du CVC ? »
4 — Culture du cathéter positive, résultat des hémocultures positif	I.L.C. certaine.
5 — Pas d'amélioration après ablation du CVC	Probable colonisation (pas d'ILC).
5 — Amélioration après ablation du CVC	Probable I.L.C.
6 — Probable I.L.C. — S. aureus, Pseudomonas	Antibiothérapie ~7 j (durée proposée avec réserve dans le schéma source).
6 — Probable I.L.C. — SCN, BGN, Candida sp.	Pas d'antibiothérapie sauf immunodépression ou maladie valvulaire ; alternative : pas d'antibiothérapie mais surveillance rapprochée et hémocultures répétées.
6 — I.L.C. certaine — S. aureus (ETO obligatoire), Pseudomonas, A. baumannii, champignon	Ablation du CVC + antibiothérapie 14-21 j.
6 — I.L.C. certaine — SCN, autre BGN	Ablation du CVC + antibiothérapie < 7 j, OU maintien du CVC + antibiothérapie 14-21 j.
7 — Persistance du sepsis > 3 j, ou hémocultures positives > 3 j	ETO obligatoire (adulte) ; recherche d'une infection profonde ; si endocardite → antibiothérapie 4-6 semaines ; si thrombophlébite → antibiothérapie 4-6 semaines ; si ostéomyélite → antibiothérapie 6-8 semaines.

Sources et traçabilité

Document source : « Réactualisation de la douzième conférence de consensus de la Société de réanimation de langue française (SRLF) : infections liées aux cathéters veineux centraux en réanimation ». J.-F. Timsit, service de réanimation médicale et infectieuse, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris. Réanimation 12 (2003) 258-265. DOI: 10.1016/S1624-0693(03)00051-3.

Comité d'organisation pour la révision : Chargés de projet — adulte : J.-F. Timsit ; pédiatrie : P. Durand. Responsables pour la commission des référentiels : B. Guidet, R. Robert, M. Wolff, S. Leteurtre. Experts — adulte : G. Nitenberg ; pédiatrie : C. Dagueville. Membres de l'ancien jury : G. Bleichner, Y. Letulzo, M. Pinsard. Experts extérieurs : J.C. Lucet, B. Souweine, L. Soufir, P. Longuet, J. Merrer, A. Lepape, F. Blot, C. Martin, G. Nitenberg, O. Mimoz, Ph. Eggiman, G. Colas, C. Brun-Buisson.

Version : reçu et accepté le 11 décembre 2002, publié 2003 — réactualisation de la 12^e conférence de consensus SRLF de 1994. Le texte final a été validé par un groupe de lecture désigné par la SRLF ; les textes des experts et la bibliographie complète sont disponibles sur srlf.org.

Méthodologie : grille Niveau (1-3) - Score d'évaluation (a-d), légende publiée intégralement par la source — voir page 1. Analyse de la bibliographie et niveau des recommandations selon la méthodologie publiée en référence [2].

URL source : <https://sfar.org/wp-content/uploads/2015/10/1-s2.0-S1624069303000513-main.pdf>

Référence citée [1] : Bleichner G, Beaucaire G, Gottot S, Letulzo Y, Marty J, Minet M, et al. Infections liées aux cathéters veineux en réanimation — Douzième conférence de consensus en réanimation et médecine d'urgence. Rean Urg 1994;3:321-30.

Référence citée [2] : Procédures de révision des recommandations (conférences de consensus, recommandations pour la pratique clinique). Réanim Urg 1998;7:357-9.

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 5 questions (définition/diagnostic ; mécanismes ; facteurs de risque/incidence/morbi-mortalité ; prévention 5.1-5.10 ; stratégie diagnostique et thérapeutique 6.1-6.2.4), la Figure 1 (algorithme, transcrite en tableau depuis un rendu visuel) et le glossaire des abréviations.

Infections liées aux cathéters veineux centraux

Q4 & Q5 — Prévention, stratégie diagnostique/thérapeutique, Figure 1 & sources



Avertissement — document de 2003 : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité des informations du texte source (dont la Figure 1, transcrite depuis un rendu visuel du PDF faute de couche texte fiable), mais ne remplace pas le texte intégral (argumentaire complet, bibliographie disponible sur srlf.org) et n'est ni éditée ni validée par la SRLF. Les pratiques de prévention et de traitement des ILC ayant évolué depuis 2003 (matériel, recommandations plus récentes), se référer à un avis spécialisé et aux recommandations actualisées avant toute décision.